

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ : Rational Laboratory Use (RLU); Influenza Virus A+B Combo test

2. ผลงานประเภท : Lean, RM, CQI

3. คำสำคัญ : Rational Laboratory Use (RLU), Influenza Combo test

4. สรุปผลงานโดยย่อ : Rational Laboratory Use (RLU) คือ การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล ซึ่งการส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการที่เกินความจำเป็นอาจทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียเงินหรือเจ็บตัวมากเกินไป หากส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการที่น้อยจนเกินไปก็อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องและแพทย์ก็อาจจะมีข้อมูลไม่มากเพียงพอในการนำไปวางแผนการรักษาผู้ป่วย ดังนั้นการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลจึงเป็นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น การลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จากเดิม 900 บาท เหลือ 350 บาทต่อราย) ผู้ป่วยเจ็บตัวจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจน้อยลง (จากเดิม 3 swab เหลือ 1 swab) เป็นต้น นอกจากนี้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 92.95)

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

5.1 เพื่อให้การส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสมเหตุผล

5.2 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

เนื่องจากในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวนมากซึ่งในราคาค่าตรวจวิเคราะห์ค่อนข้างสูง ซึ่งบางรายการตรวจวิเคราะห์ราคาไม่สูงแต่มีการส่งตรวจบ่อยจนเกินความจำเป็น ทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียเงินจนเกินความจำเป็นหรือเจ็บตัวจากการถูกเก็บตัวอย่างหลายครั้งเนื่องจากเก็บตัวอย่างไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคทำให้ต้องสั่ง order เพิ่ม พยาบาลต้องเก็บตัวอย่างของผู้ป่วยเพิ่มซึ่งบางครั้งก็โดนตำหนิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากการทำหัตถการผู้ป่วยหลายครั้งจนญาติผู้ป่วยไม่พอใจ ทั้งนี้ทางกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของประเทศในโครงการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use; RLU) ซึ่งร่วมมือกับทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมงานด้านดิจิทัลทางการแพทย์ ทีมงานด้านการเงิน ทีมงานด้านงานเรียกเก็บและงานประกันสุขภาพของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลของสถาบันสุขภาพเด็กฯขึ้น ในปี พ.ศ. 2567 และได้ดำเนินการประชุมทีมคณะกรรมการจนสามารถเริ่มต้นดำเนินการเรื่องแรก คือ การตรวจคัดกรองหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza A/B) ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) และโควิด (SAR-CoV2) ซึ่งมีการส่งตรวจจำนวนมาก (ประมาณ 16,767 ต่อปี) โดยการส่งตรวจเป็นการแยกตรวจแบบเดี่ยว (หมายถึงการตรวจคัดกรองหาแอนติเจน 1 เชื้อก่อโรคต่อ 1 ตลับทดสอบ) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยต้องถูกเก็บตัวอย่างจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab; NP swab) จำนวน 3 swab เพื่อให้สามารถส่งตรวจได้ครบทั้ง 3 เชื้อก่อโรค ซึ่งราคาในการส่งตรวจแต่ละรายการ คือ การตรวจคัดกรองหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza A/B) ราคา 350 บาท ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ราคา 350 บาท และโควิด (SAR-CoV2) ราคา 200 บาท ซึ่งรวมทั้งหมด คือ 900 บาท และจากการประชุมทีมคณะกรรมการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลทำให้ตระหนักถึงความลำบากของผู้ป่วย การทำงานหลายขั้นตอนบนความ

เสียงของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จนเกิดเป็นโอกาสพัฒนาในการปรับเปลี่ยนการใช้ชุดตรวจคัดกรองหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza A/B) ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) และโควิด (SAR-CoV2) จากแบบเดี่ยวเป็นแบบรวม (Combo) โดยใช้ชื่อรายการตรวจวิเคราะห์ว่า Influenza Virus A+B Combo รหัส IH10 ราคา 350 บาท ซึ่งทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยจากเดิม 900 บาท เหลือ 350 บาท ลดการบาดเจ็บตัวหรือการเจ็บตัวของผู้ป่วยลงเพราะจากเดิมต้องเก็บ NP swab 3 swab เปลี่ยนเป็น 1 swab ลดข้อร้องเรียนของญาติผู้ป่วยลงและทำให้แพทย์สามารถในผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. กิจกรรมการพัฒนา : ระบุ

7.1 นำข้อร้องเรียน/ เสนอแนะจากผู้รับบริการเข้าร่วมประชุมทีมงานภายในหน่วยงานภูมิคุ้มกันวิทยา เพื่อรับทราบและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

7.2 นำปัญหาเข้าร่วมปรึกษาในที่ประชุมระดับหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์

7.3 นำโครงการ Rational Laboratory Use (RLU) มาเป็นกลไกการขับเคลื่อนการทำงานโดยยึดหลักการทำงานให้เรียบง่าย (Lean) ลดความเสี่ยง (RM) ในการทำงานและการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ (Teamwork)

7.4 นำข้อร้องเรียน/เสนอแนะจากผู้รับบริการเข้าประชุมกับทีมคณะกรรมการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล เพื่อฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องและระดมความคิดเห็นจนเกิดเป็นแนวทางการทำงานที่ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนการใช้งานชุดตรวจจากชุดตรวจแบบเดี่ยว (Single test) เป็นแบบรวม (Combo) เก็บตัวอย่าง NP swab ลดลงเหลือเพียง 1 swab จัดทำรหัสการตรวจวิเคราะห์ที่ราคาลดลง

7.5 ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการดำเนินงานให้ทราบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7.6 ดำเนินการทดสอบระบบ/ แนวทางที่วางแผนไว้

7.7 รับฟังข้อเสนอแนะ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและวัดผลการประเมินการทำงานที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 จนถึงปัจจุบัน

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

8.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 80

8.2 จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการเก็บตัวอย่าง NP swab ที่มากเกินไปลดลงเท่ากับ 0

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ : ระบุ

9.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการส่งตรวจ Influenza Virus A+B Combo (ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 92.95 เกณฑ์มากที่สุด)

9.2 ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ

10. บทเรียนที่ได้รับ :

10.1 การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรม RLU ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ สามารถพัฒนาได้อีกหลายเรื่องหากทีมงานมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนางานเพื่อผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีขึ้น คนทำงานลดความเสี่ยงจากการทำงานและสามารถทำงานอย่างมีความสุข

10.2 ควรทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

10.3 กิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้จริงและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกฝ่ายทั้งสถาบันสุขภาพเด็กฯ

10.4 มีการนำชุดตรวจในลักษณะแบบรวม (Combo) เข้าร่วมกับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
กรมการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2569

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน : ระบุ

นางสาวอมรวิทย์ จุฑาแดง นักเทคนิคการแพทย์ นางสาวอัจฉรา พันธุ์เจริญ นักเทคนิคการแพทย์ นางสาว
ธัญวรรณ อุ่ทองมาก นักเทคนิคการแพทย์ นางสาวภรณ์รวิ ศรีประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย์ งานภูมิคุ้มกัน
วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ เบอร์โทร 3518 และ e-mail :
parparcoonan@gmail.com

12. ขอขอบคุณ ทีมคณะกรรมการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลและทีม
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ที่ผลักดันจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ทีมพัฒนา
คุณภาพของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่ให้โอกาสได้นำมาเผยแพร่และคอยสนับสนุนแนวทางการ
ดำเนินงานมาโดยตลอด

แบบประเมินตนเองในการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Self Check)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลงาน

ชื่อผลงาน Rational Laboratory Use (RLU); Influenza Virus A+B Combo test

หน่วยงาน ภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โทร 3518

หมวดหมู่ของผลงานการพัฒนาคุณภาพ Lean, RM, CQI

☐ เคยส่งผลงานเรื่องนี้เข้าร่วมงาน ☒ ยังไม่เคยส่งผลงานเรื่องนี้เข้าร่วมงาน

ลำดับที่	รายการ	คะแนนประเมินตนเอง				
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
1	ระดับความสำเร็จของผลงาน	☐ อยู่ในกระบวนการคิด	☐ กำลังดำเนินการ	☐ ต่อยอดจากของเดิม	☐ สำเร็จแล้ว	☒ มีการขยายผลไปหน่วยงานอื่น
2	รูปแบบการทำกิจกรรม	☐ ยังไม่ชัดเจน	☐ พัฒนาจากแนวทางที่มีอยู่แล้ว	☐ ทดลองทำขึ้นใหม่	☒ มีลักษณะของ PDCA/KM/R2Rชัดเจน	☐ ยังไม่มีการทำมาก่อนในประเทศไทย
3	ผลลัพธ์ของการพัฒนา	☐ ยังไม่ชัดเจน	☐ มีความชัดเจน	☐ ใช้ประโยชน์ได้ดี	☐ ประหยัดทรัพยากร	☒ ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น/หรือภายนอก
4	ความร่วมมือต่อการนำผลงานไปใช้	☐ คนเดียว	☐ วิชาชีพเดียว	☐ 2 วิชาชีพ	☐ ทีมสหสาขาภายในหน่วยงาน	☒ เป็นทีมสหสาขาระหว่างหน่วยงาน
5	ผลกระทบของการพัฒนา	☐ ใช้ในหน่วยงาน	☐ ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น	☒ ใช้ร่วมกับนอกสถาบัน	☐ สามารถเปรียบเทียบกับภายนอกได้	☐ ได้รับรางวัลระดับประเทศ

รวมคะแนน 22 คะแนน

